

Status abdominal

Abréviations:

L'ART DU TOUCHER RECTAL

- o AAA: anévrisme de l'aorte abdominale
- o EF: état fébrile
- o FID/FIG: fosse iliaque D/G
- o FR: facteur de risque
- o GEU: grossesse extra-utérine
- o HD: hypochondre droit
- o IVDU: intra-venous drug user

Objectifs cahier de module B3.8

- Anamnèse
 - Mener une anamnèse alimentaire et nutritionnelle simple
 - Connaître les spécificités nutritionnelles des personnes âgées
 - Rechercher, à l'aide d'une anamnèse dirigée, les symptômes de troubles digestifs
 - Identifier dans une anamnèse les plaintes digestives/abdominales ayant une origine extra digestive
 - Mener une anamnèse proctologique
- Signes cliniques
 - Décrire et reconnaître les principaux signes de pathologies abdominales
 - Effectuer les principales manœuvres diagnostiques spécifiques aux pathologies chirurgicales digestives
 - Décrire l'examen proctologique

Solution hydroalcoolique dès qu'on rentre dans la salle

Anamnèse en général

- Caractérisation plainte
- Antécédents personnels (maladies, opérations, hospitalisations)
- Antécédents familiaux
- Anamnèse personnelle
 - Fièvre
 - Vaccination
 - Voyages récents
 - Drogues, alcool, tabac
- Médicaments
- (Psychosociale)
- + Anamnèse abdo
- Demander si le patient a des questions

A L'ECOS : rester systématique même avec le stress

Anamnèse – Caractérisation plainte

1. Localisation ET irradiation (si localisation précise, souvent atteinte du péritoine pariétal)
2. Qualité (constrictive, brûlante, électrique, aiguilles, coups de poignard)
3. Intensité 0-10
4. Chronologie (début, durée, évolution, 1^{er} épisode)
5. Condition de survenue (après un repas, ...)
6. Facteurs modifiants (soulageant, aggravant et médicaments)
7. Manifestations associées (fièvre, fatigue, modification du poids, ...)

Anamnèse abdo

- Appétit (alimentation + contenu dernier repas, fausse route, dysphagie)
- Nausées/vomissements (chronologie, couleur, contenu)
- Selles/transit (changements , fréquence, quantité, consistance, couleur, sang, odeur, gaz)
- Urines (fréquence, quantité, brûlures, couleur, odeur)
- Pyrosis
- Ictère, FR hépatite (vaccination, tatouage récent, voyages, IVDU, rapports non protégés)
- Grossesse (contraception, désir de grossesse, dernières règles, méno-métroragies)
 - Toute douleur abdominale chez une femme en âge de procréer est une GEU jusqu'à preuve du contraire
 - **Demander un test de grossesse**

Anamnèse alimentaire: 5A

- **A**pathie (moral)
- **A**sthénie (force, activités)
- **A**norexie (appétit, exclusion alimentaire, restriction, purges, crises boulimie)
- **A**maigrissement (poids de forme)
- **A**pyrexie (état subfébrile)

Red Flags

- | | |
|---|---|
| ○ Perturbations signes vitaux | -> Etat de choc |
| ○ Hypotension orthostatique | -> GEU, rupture AAA |
| ○ Perte pouls fémoraux, douleur interscapulaire | -> Dissection aortique |
| ○ Défense/détente | -> Péritonite |
| ○ Absence de bruits digestifs, douleur brusque | -> Perforation digestive, iléus paralytique |
| ○ Douleurs intenses et status normal | -> Infarctus mésentérique (si FRCV) |
| ○ Douleur épigastrique (surtout femmes) | -> Infarctus du myocarde |

Associations graves possibles mais pas absolues entre examen clinique et pathologies

Status

Se désinfecter à nouveau les mains

1. Installation correcte (se positionner à la droite du patient)
2. Observation
3. Auscultation
4. Percussion
5. Palpation
6. Examens ciblés

Solution hydroalcoolique

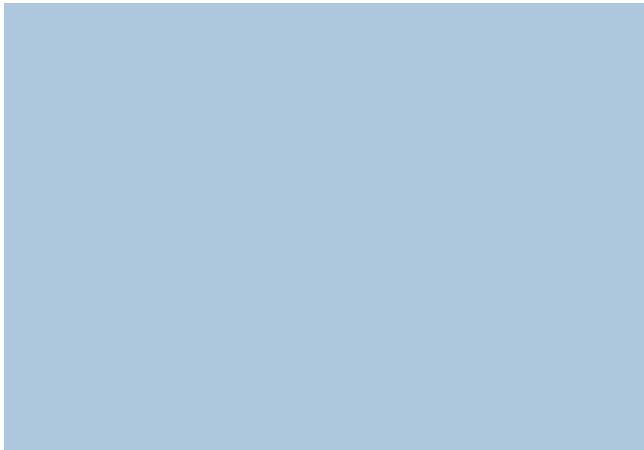
A L'ECOS : auscultation avant percussion et palpation !



Installation

- Patient/e/x couché/e/x (coussins et tout et tout)
- Bras le long du corps
- Jambes décroisées
- Enlever T-shirt (hépatite suite à nouveau tatoo l'année passée)
- Ceinture et premier bouton défaits
- S'assurer que le patient n'ait pas besoin d'aller aux toilettes
- Frotter ses mains (comme Sensei Miyagi)

A l'ECOS: montrer qu'on fait tout ça = points easy



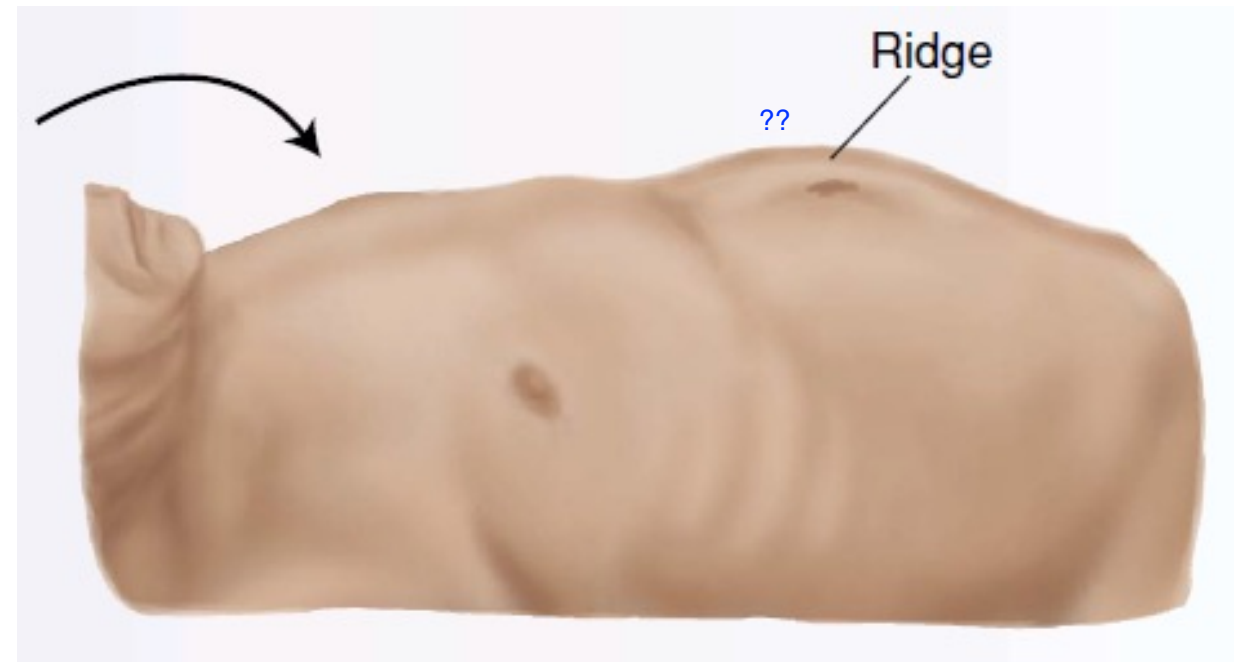
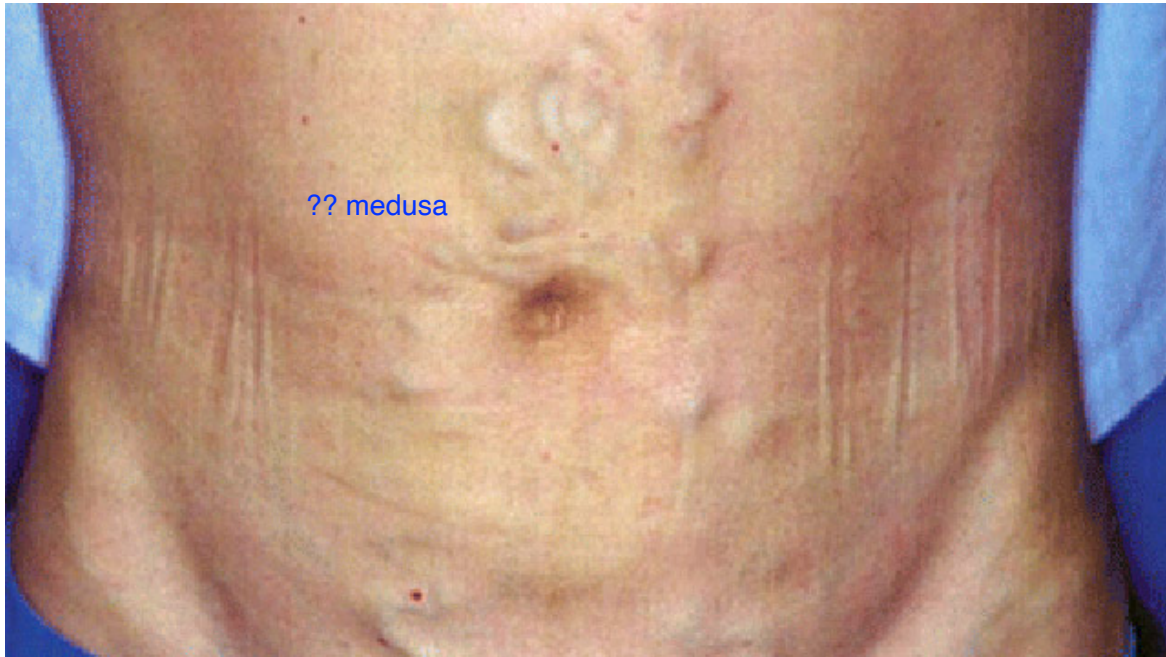
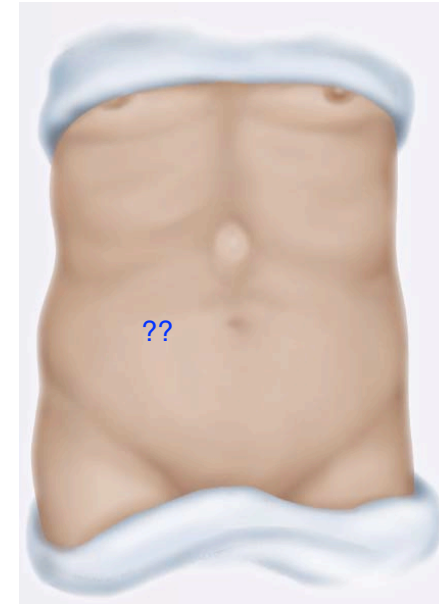
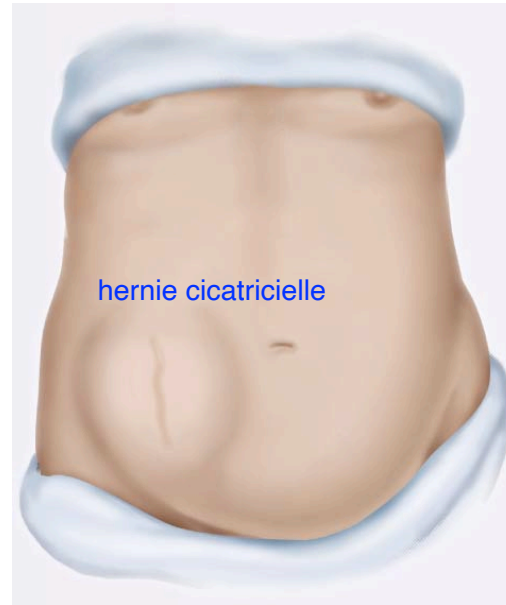
Observation

- L'observation commence dès l'entrée dans la salle
- Toujours observer le visage pendant le status
- Forme et contours (symétrie, ombilic, augmentation du périmètre abdominal, voussure)
- Peau
 - Cicatrices, hernies, veines dilatées (caput medusae), ictère, rash, vergetures pourpres, pilosité, ecchymoses, diastase, signes de Cullen et de Grey Turner
- Pulsations de l'abdomen -> Alien? -> Nope, possible AAA (normal chez les jeunes sveltes)

A l'ECOS: décrire tout ce qu'on observe même si c'est normal

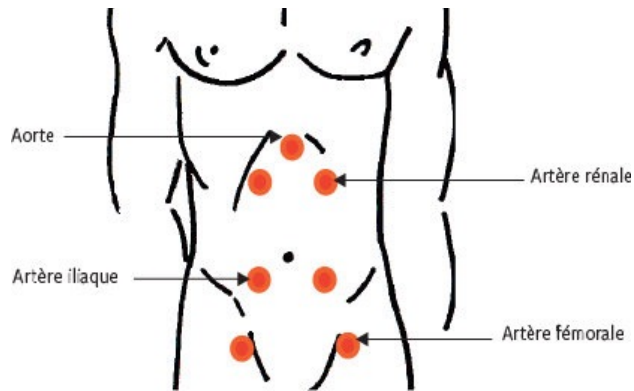
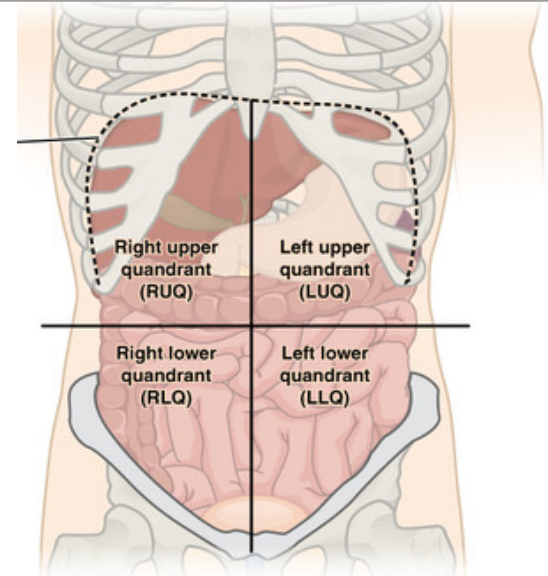
Ex: «Votre ventre est symétrique, sans cicatrices, pas de veines dilatées, couleur normale, ...»





Auscultation

- Demander si douleur -> commencer à l'opposé
- 4 cadrans avec la **membrane**
 - Fréquence augmentée -> diarrhée, médicaments
 - Fréquence diminuée et/ou bruits métalliques -> iléus
 - Si on n'entend rien -> va et vient en profondeur pour stimuler les intestins



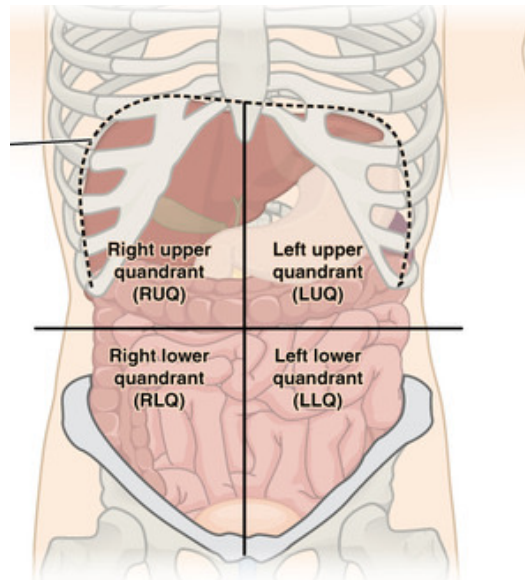
- Artères avec la **cloche** (aorte, rénales, iliaques, fémorales)
 - Si souffle -> athérosclérose

Percussion – Matité/Tympanisme

- 4 cadrans (douloureux en dernier) « Je vais tapoter »
 - Matité localisée -> masse
 - Matité déclive avec tympanisme central -> ascite
 - Tympanisme -> iléus, gaz (tympanisme normal en région gastrique)
- Foie : délimitation sur la ligne médio-claviculaire
- Rate : de médial à latéral (normal si tympanisme dans la zone de Traub)
- Rein : patient assis -> recherche de pyélonéphrite
 - Poser sa main à plat sur un rein dans le dos et taper sur sa main

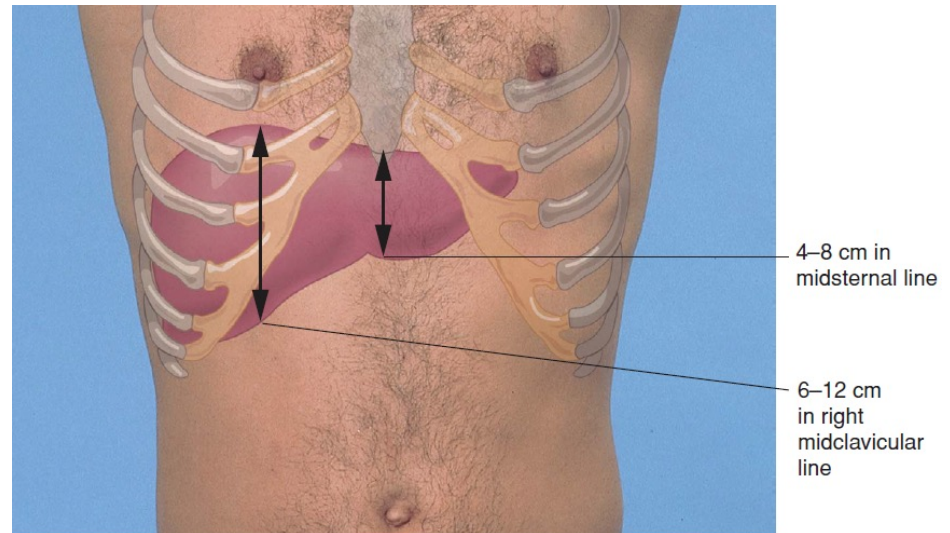
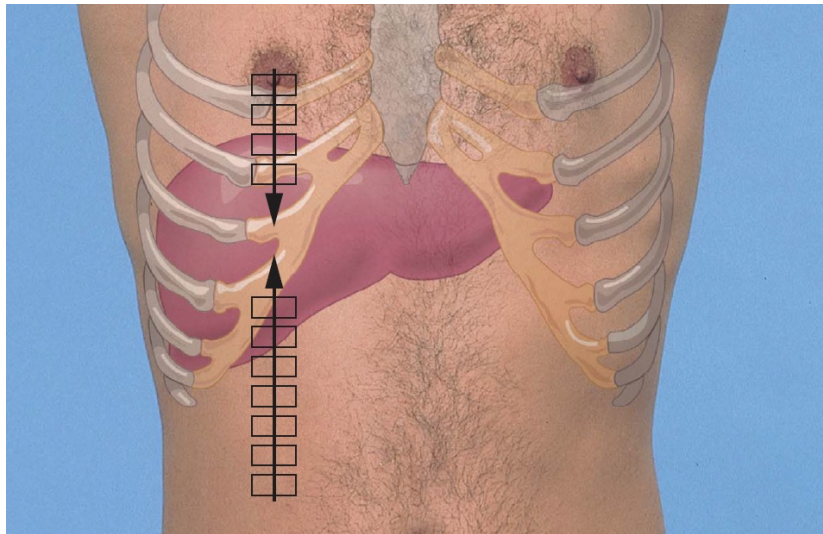
Percussion – 4 cadrans

- 4 cadrans (douloureux en dernier) « Je vais tapoter »
 - Matité localisée -> masse
 - Matité déclive avec tympanisme central -> ascite
 - Tympanisme -> iléus, gaz (tympanisme normal en région gastrique)



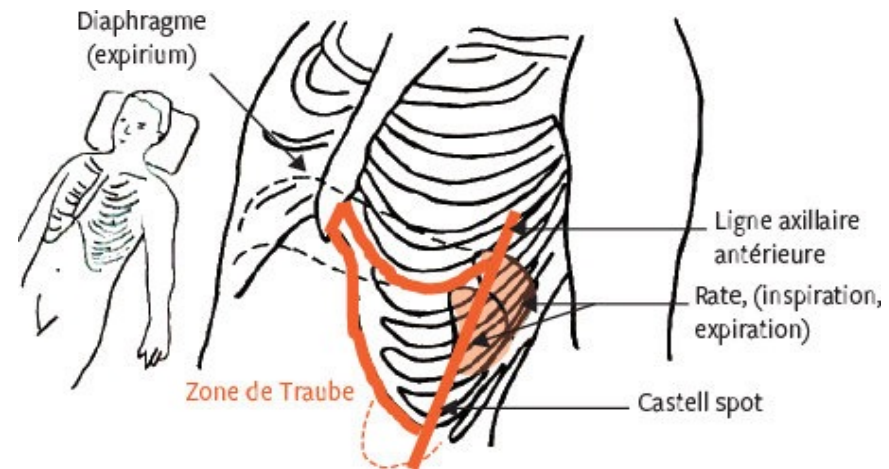
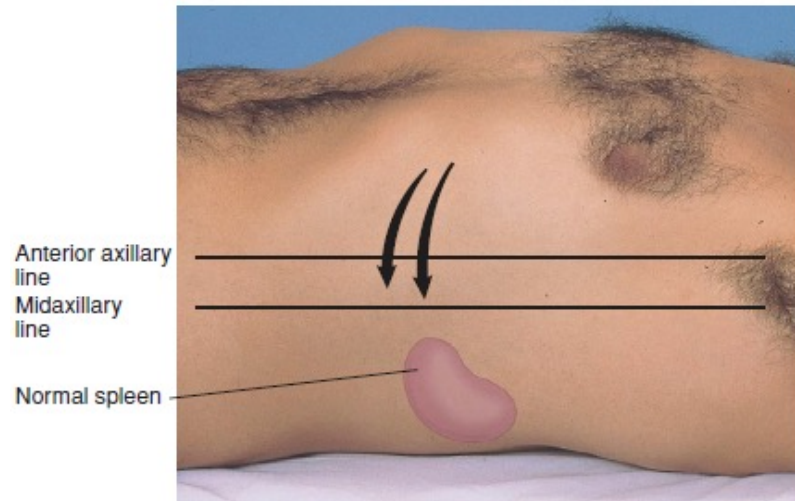
Percussion – Foie

- Foie : délimitation sur la ligne médio-claviculaire



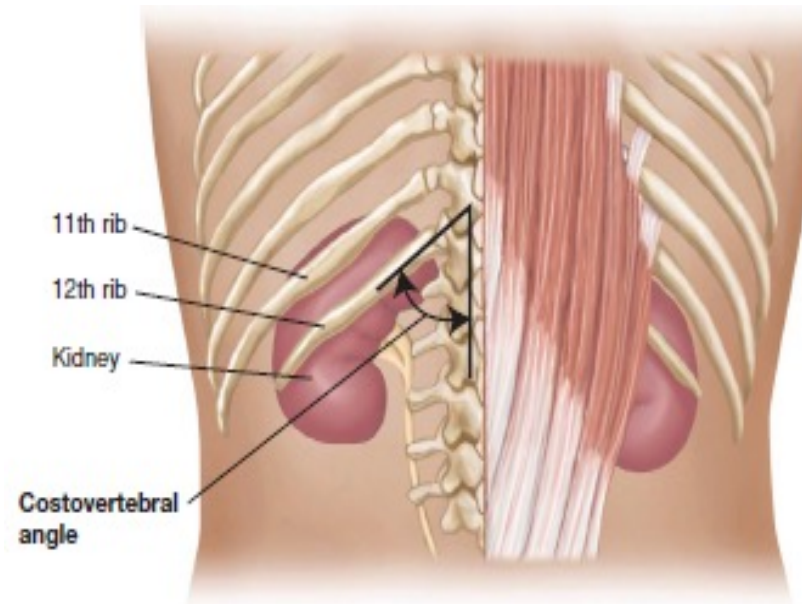
Percussion – Rate

- Rate : de médial à latéral (normal si tympanisme dans la zone de Traub)

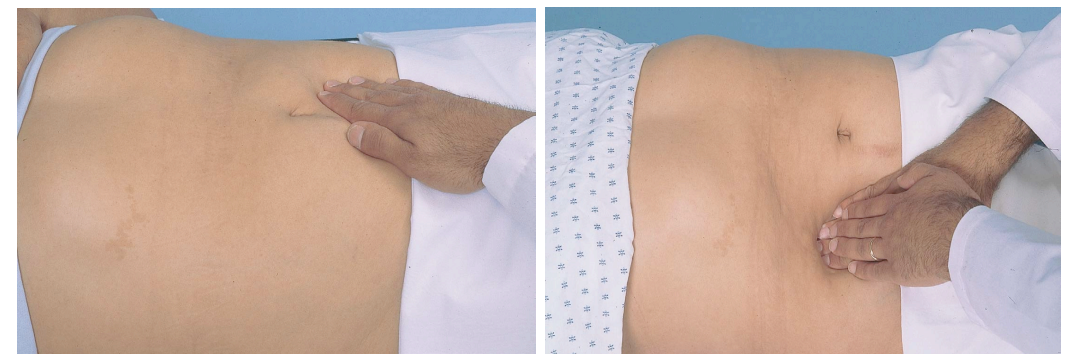


Percussion – Reins

- Rein : patient assis -> recherche de pyélonéphrite des deux côtés
 - Poser sa main à plat sur un rein dans le dos et taper sur sa main
 - Commencer doucement

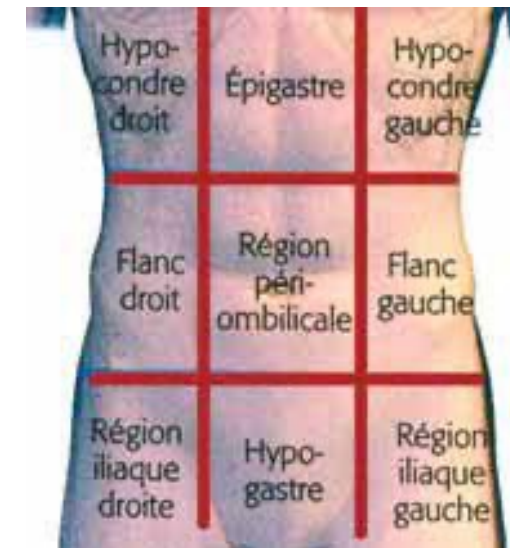


Palpation générale



- **4 cadrans** (douloureux en dernier) en regardant le visage du patient
 - **Superficielle** à une main -> rassurer et détendre le patient
 - **Profonde** à deux mains -> localiser et caractériser une masse (dimension, forme, consistance, mobilité)
- **Défense:**
 - contraction réflexe des abdos s'opposant à la palpation profonde, localisée ou généralisée
- **Détente**
 - douleur au retrait brusque des mains en palpation profonde

*Utiliser les noms des 9 régions pour localiser le problème
(pour transmission de l'info)*

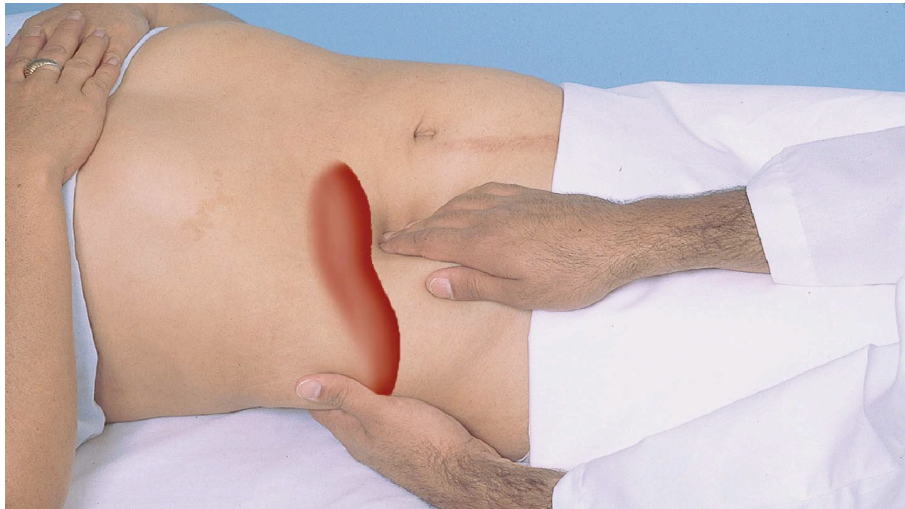


Palpation – Organes

- Foie
 - main G sous le foie, main D palpe. Technique du crochet si patient obèse. Commencer la palpation assez bas pour ne pas louper le bord inf du foie.
- Rate
 - main gauche sous la rate, main D palpe. Normalement pas palpable. Commencer très bas.
- Reins
 - 1 main dans le dos et l'autre palpe profondément
- Aorte
 - à deux mains, profondément en essayant de “pincer” l'aorte. Recherche AAA, commencer large
- Hernie
 - demander au patient de lever la tête ou tousser pour la faire ressortir
- Ganglions inguinaux

Palpation – Foie

- Main G sous le foie, main D palpe.
- Technique du crochet si patient obèse
- Commencer la palpation assez bas pour ne pas louper le bord inf du foie.



Palpation – Rate

- Main gauche sous la rate, main D palpe.
- Normalement pas palpable. Commencer très bas.



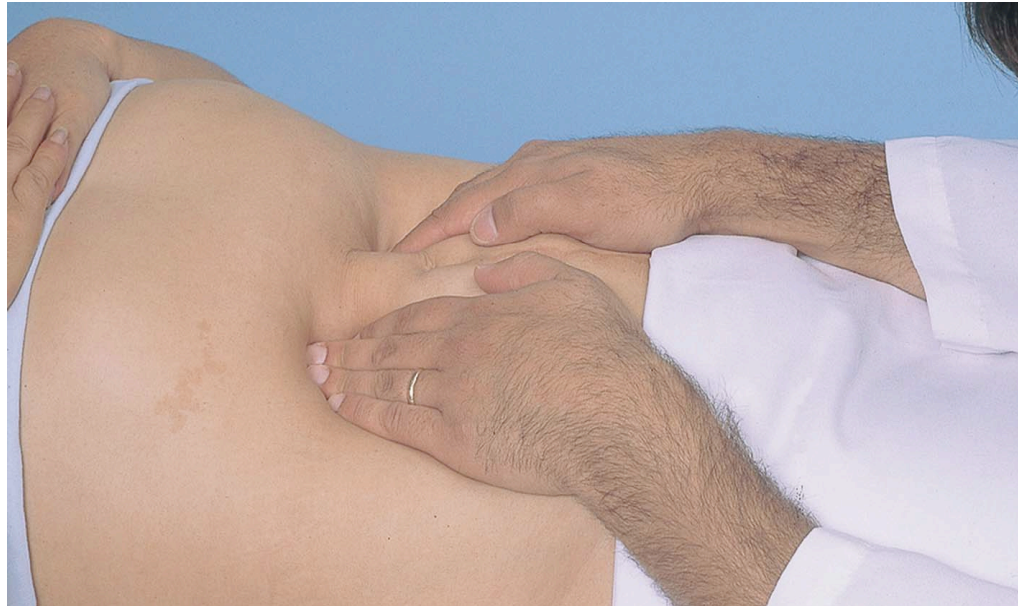
Palpation – Reins

- 1 main dans le dos pour pousser le rein vers l'avant, l'autre palpe profondément
- Palper les deux reins (à droite main G dessous, à gauche main D dessous)



Palpation – Aorte

- A deux mains. Profondément en essayant de “pincer” l’aorte entre ses deux mains.
- Commencer large, recherche AAA.



Toucher rectal

- TR si
 - modification transit
 - rectorragie/méléna
 - douleur/prurit anal
 - diminution du jet urinaire chez l'homme
 - suspicion lésion moelle (S2-S4)
 - => **presque toujours si plainte abdo !!!**
- Comment faire
 - décubitus latéral, genoux contre la poitrine
 - inspection des zones sacro-coccygienne
 - mettre un gant et lubrifier l'index
 - demander de pousser
 - introduire le doigt en direction du nombril
 - évaluer le tonus sphinctérien (demander de serrer le doigt)
 - palper en faisant un 360° avec le doigt (masse, irrégularité, douleur)
 - regarder couleur des selles et présence de sang sur le doigt à la fin

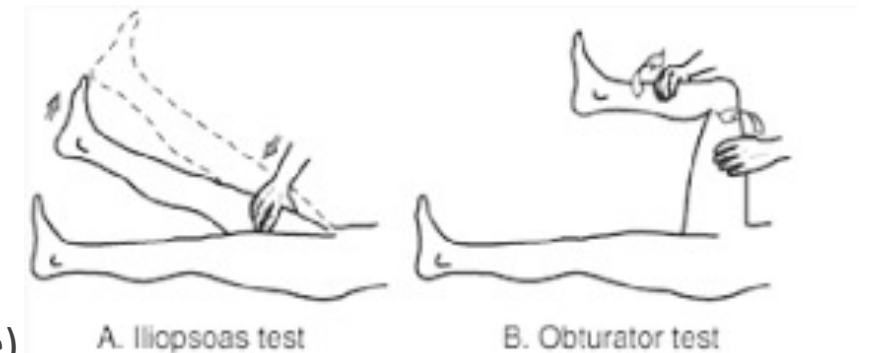
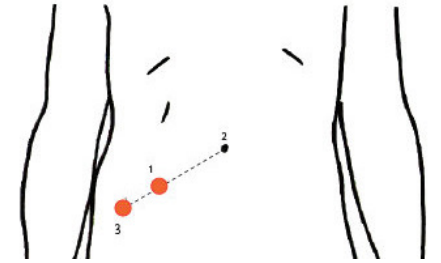
TOUJOURS le mentionner à la fin du status abdo à l'ECOS
(Masse, polypes, sang, fécalome, tonus sphinctérien, ...)

Examens ciblés

- Servent à mettre en évidence une pathologie précise
- Ne sont pas parfait niveau sensibilité et spécificité
- Pathologies recherchées
 - Appendicite
 - Ascite
 - Cholécystite
 - Péritonite
 - Sigméïdite

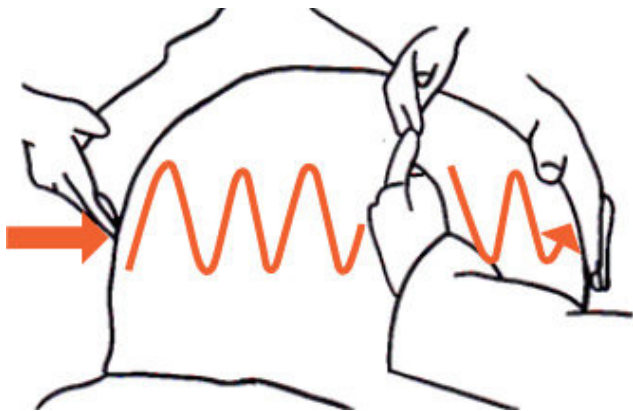
Appendicite

- **Point de McBurney**
 - palpation point aux 2/3 entre nombril et crête iliaque antérieure
- **Signe de Rovsing**
 - palpation profonde en FIG qui provoque une douleur en FID
 - repousse l'air du côlon gauche dans la région iléo-caecale inflammée ce qui la distend
 - permet de différencier une pathologie intestinale d'une pathologie annexielle
- **Signe du psoas**
 - demander au patient de lever sa jambe
- **Signe de l'obturateur**
 - flexion hanche 90° + rotation interne de la jambe
 - étirement muscle obturateur inflamé en contact avec appendicite)



Ascite

- Accumulation de liquide dans l'abdomen
 - sur cirrhose, insuffisance cardiaque, carcinose péritonéale
- Percussion: matité déclive mouvante (penser à liquide + air dans un ballon)
 - le liquide qui descend provoque une matité déclive avec un tympanisme au-dessus
 - change en fonction de la position
- **Signe du flot**



Cholécystite

- Douleur dans l'hypochondre droit
- **Signe de Murphy**
 - pendant la palpation profonde sous le rebord costal droit, demander au patient d'inspirer profondément
 - s'il bloque son inspiration à cause de la douleur -> signe positif
- **Triade de Charcot**
 - douleur en HD + ictère + fièvre

Péritonite

- Détente ($\pm$ défense)
- Douleur parfois même avec une faible vibration de l'abdomen
 - lors de la percussion
 - adulte: se laisser tomber de la pointe des pieds sur les talons
 - enfants: sauter pieds joints d'un escabot

Sigmoïdite

- Pas forcément d'examen spécifique mais :
 - Présentation: douleur spontanée et à la palpation en FIG, EF et trouble du transit
 - FR : sédentarité, régime pauvre en fibres